Dall'Autismo alla Neurodiversità

David Vagni, MSc.
Vice-Presidente di «Spazio Asperger ONLUS»
Ricercatore CNR
Direttore Scientifico di CuoreMenteLab
PhD Student at LMU – Learning Science

Falsi miti sulle persone nello Spettro Autistico

- Non hanno emozioni
- Somigliano a *Rain Man*
- Non hanno amici o non vogliono stare con le persone
- Non guardano negli occhi
- Non si sposano
- "Non puoi essere asperger perché ti avrebbero dovuto diagnosticare nell'infanzia"
- "Non può essere asperger perché da piccolo non si fissava a guardare la lavatrice"
- "è una fase, passerà"
- L'autismo è una forma di schizofrenia

Falsi miti sulle persone nello Spettro Autistico

- Non capiscono l'ironia e non hanno il senso dell'umorismo
- Sono tutti uguali
- Gli autistici sono tutti geni. Gli autistici sono ritardati/disabili.
- Pensano per immagini
- Percepiscono solo i dettagli
- La mamma frigorifero ("La fortezza vuota" di Bruno Bettelheim)
- La madre coccodrillo di Jacques Lacan ("Il Muro. La Psicoanalisi alla prova con l'Autismo" di Sophie Robert – Francia, 2011)

SCARICA IL LIBRO GRATUITO!

http://**spazioasperger.it/rispostesemplici/**

Questo libro nasce per rispondere in modo semplice ma preciso alle tante domande riguardo l´Autismo, la Sindrome di Asperger e lo Spettro Autistico in generale. Per poter raggiungere la mente ed il cuore delle persone è necessario "bonificare" gli stereotipi che troppo spesso contrastano l´inclusione e la comprensione delle persone autistiche.

Buone prassi per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche, informazioni e curiosità, prendono vita in un libro di facile lettura.

Storia e criteri diagnostici

Quasi in contemporanea vengono descritti due gruppi di bambini.
Per alcuni versi simili, per altri molto diversi.

Leo Kanner (1943)

Hans Asperger (1944)

HANS ASPERGER (1906-1980)

- Problemi di teoria della mente e intellettualizzazione degli affetti
- Scarse capacità di fare amicizie
- Scarsa reciprocità nella conversazione
- Dedizione intensa a interessi insoliti
- Percezione sensoriale accentuata
- Goffaggine motoria
- EDUCABILITÀ

"I bambini autistici devono imparare le abilità sociali in modo sistematico, nello stesso modo in cui devono imparare la lezione a scuola"
(Temple Grandin)

Abbiamo molte misdiagnosis perché non sappiamo riconoscere l'Autismo quando si nasconde

Quando l'Autismo si nasconde

- Giftedness e Asperger: il caso dei *Twice Exceptional* (2E)
- Camaleontismo sociale e maschera (il profilo delle donne asperger)
- Le difficoltà possono diventare più pronunciate nella transizione verso l'età adulta, quando le esigenze di autonomia aumentano.
- *Le richieste maggiori superano le capacità*

Quando l'Autismo si nasconde

- Molte persone autistiche con problemi lievi passano attraverso l'infanzia e l'adolescenza senza ricevere una diagnosi
  - allargamento dei criteri diagnostici negli ultimi anni
  - alta intelligenza e capacità verbale in grado di compensare e camuffare le difficoltà
  - Sintomi scambiati per espressioni di altri problemi psichiatrici o psicologici (Gillberg 2002)
  - Altri disturbi psichiatrici e sintomi spesso coesistono con l'ASD (Bejerot e Wetterberg 2008)

Missdiagnosis (Inghilterra)

- In Gran Bretagna, la prevalenza di adulti autistici non diagnosticati è risultato essere dell'1 % (Brugha et al. 2009)
- In un grande studio britannico , Barnard et al. (2001) hanno trovato che il 29 % delle persone con autismo ad alto funzionamento e il 46 % di quelli con Sindrome di Asperger non aveva ricevuto questa diagnosi fino alla tarda adolescenza o l'età adulta

Comorbidità dell'Autismo

Bambini

- ADHD 35%
- Attenzione 60-70%
- DOP/PDA 15%
- **Dislessia 15-20%**
- NVLD 20%
- Disturbi d'ansia: 40-50%

Research in Autism Spectrum Disorders

Comorbidity in autism spectrum disorder: A literature review

Arlene Mannion, Geraldine Leader *

Adulti

- Schizofrenia: 5-15%
- Bipolare: 10-30%
- Depressione: 20-40% attuale (70% nel corso della vita)
- Disturbi d'ansia: 40-50%
- Disturbi di Personalità: 70-90%
- DOC: 44-60%
- Disturbi della Condotta Alimentare 20-30%

Che cos'è realmente l'autismo?

- L'Autismo è una condizione legata ad uno sviluppo neurobiologico atipico.
- L'autismo è definito attraverso la manifestazione comportamentale.
- **L'Autismo quindi è definibile come un insieme (sindrome), eterogeneo (spettro), di comportamenti (sintomi) che possono avere un numero molto elevato di cause e presentazioni diverse.**

14

Genetica ed ereditarietà (la mela non cade lontano dall'albero)

- A differenza dell'autismo classico, la **componente genetica *ereditaria*** è molto più marcata.
- Maggior numero di disturbi psichiatrici in famiglia.
- Maggiore presenza di genitori scienziati o artisti.
- Elevata presenza di tratti autistici nei genitori (presente nell'autismo ma molto più negli Asperger!)

Autism Res. Author manuscript; available in PMC 2014 Apr 1.
Published in final edited form as:
Autism Res. 2013 Apr; 6(2); 134–143.
Published online 2013 Feb 20. doi: 10.1002/aur.1272

PMCID: PMC3661668
NIHMSID: NIHMS431204

The Broad Autism Phenotype Questionnaire: Prevalence and Diagnostic Classification

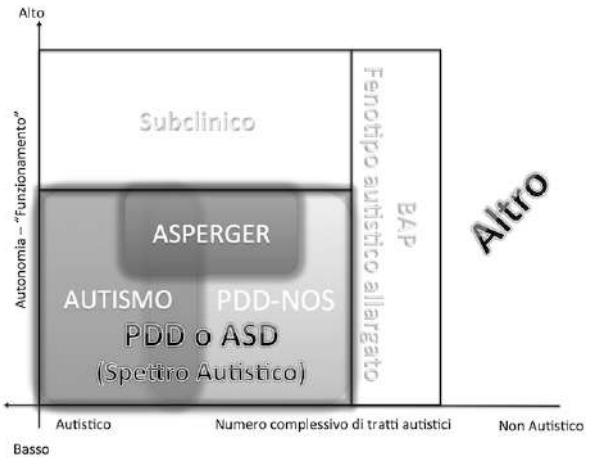
Noah J. Sasson,[1] Kristen S. L. Lam,[2] Debra Childress,[2] Morgan Parlier,[2] Julie L. Daniels,[2,3] and Joseph Piven[2]

Author information ▶ Copyright and License information ▶

Cosa significa "Spettro"?

- Spettro si può riferire alla natura **dimensionale** delle caratteristiche cardine di una condizione all'interno della popolazione clinica (la differente severità dei sintomi)
- Spettro si può anche riferire alla **continuità** delle caratteristiche tra la popolazione clinica e la popolazione generale. Questa visione richiede la presenza di "tratti" distribuiti uniformemente in tutte le persone.
- Spettro si può riferire anche ai diversi **sottogruppi**, ai diversi tipi qualitativamente distinti pur rientrando nella stessa macro-categoria.

Spettro Autistico: tratti, funzionamento generale e significatività clinica



Contents lists available at ScienceDirect

Research in Developmental Disabilities

The ESSENCE in child psychiatry: Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations☆

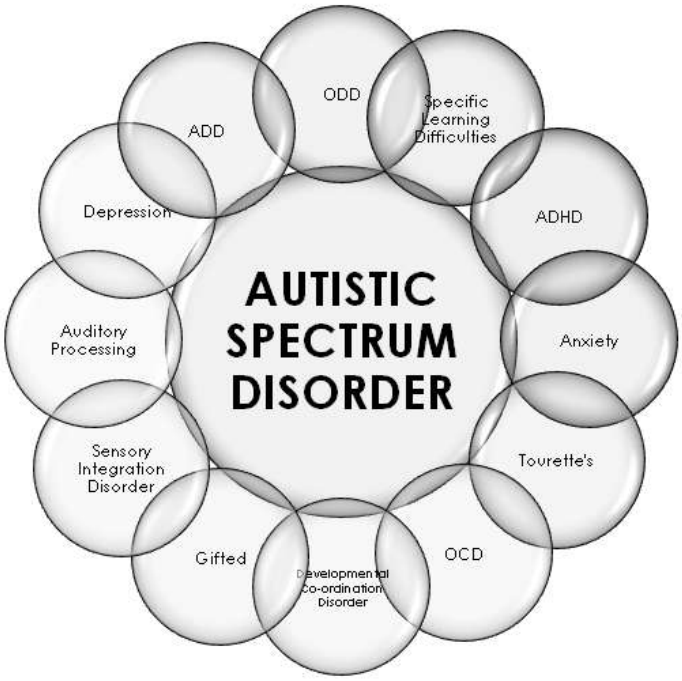
Christopher Gillberg

Institute of Neuroscience and Physiology, Child and Adolescent Psychiatry, University of Göteborg, Sweden

La difficoltà nel separare da un punto di vista genetico ed eziologico le diverse diagnosi ha portato Gillberg (2010) a coniare il termine **ESSENCE** (***Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations*** – Sindromi Sintomatiche precoci che elicitano una valutazione clinica) per riferirsi alla realtà vissuta dai bambini e dai loro genitori che presentino sintomi d uno sviluppo atipico prima dei 5 anni in alcuni dei seguenti campi:

ESSENCE
oltre lo Spettro

- a) sviluppo generale,
- b) linguaggio e comunicazione,
- c) relazione sociale,
- d) coordinazione motoria,
- e) attenzione,
- f) livello di attività,
- g) comportamento,
- h) tono dell'umore,
- i) sonno/alimentazione.



ESSENCE

- il 17% dei bambini (1 su 6) ha problemi riconducibili all'ESSENCE.
- i singoli fattori di ogni condizione sono distribuiti uniformemente all'interno della popolazione generale e per nessuno esiste un cut-off "naturale" o si può evincere una distribuzione bimodale
- i problemi socio-comunicativi, solitamente concepiti come nucleari dell'autismo, in realtà si presentano con un tasso molto elevato (6% nella popolazione generale) in quasi tutte le altre condizioni.

DSM-5

- Sintomi nucleari (2 domini: socio-comunicativo e comportamenti ristretti o ripetitivi)
- Quoziente intellettivo
- Sviluppo del linguaggio
- Funzionamento (autonomie)
- Comorbidità psichiatriche e mediche.

DSM-5

- I sintomi sono "*ever*". Non serve siano presenti oggi, basta che lo siano stati in passato.
- Criterio D. L'*insieme* delle caratteristiche deve provocare difficoltà significative clinicamente da un punto di vista sociale o occupazionale o in altre aree del funzionamento (compreso il benessere personale). [Clinico – Subclinico]
- Criterio E. Nel caso di disabilità intellettiva, il deficit sociale deve essere superiore a quanto ci si aspetterebbe dal *solo* ritardo mentale.

DSM-5
Diversi gradi di compromissione

- La severità della condizione è basata su 3 livelli (grave, medio, lieve) per ognuno dei due domini.
- **Grave**: richiede supporto molto sostanziale – le difficoltà impediscono l'autonomia e l'interazione
- **Medio**: richiede supporto sostanziale – le difficoltà rendono difficile l'autonomia e l'interazione ma riesce nelle situazioni più semplici.
- **Lieve**: richiede supporto – *le difficoltà si manifestano solo in ambienti che non danno il supporto necessario ma possono non manifestarsi se c'è anche un minimo di supporto.*

Criteri del DSM-5
299.00 (F84.0)

A. Deficit persistenti nella comunicazione ed interazione sociale in molteplici contesti, come manifestato da *tutti* i seguenti punti, oggi o nella *storia* dello sviluppo.

- *Pervasivi e continuativi nello sviluppo*
- *Necessità di avere diverse fonti per raccogliere i dati (osservazione, self-report, genitori, scuola, etc.)*
- *Molti individui hanno ritardi o assenza di linguaggio, in espressione e/o ricezione, oppure un linguaggio troppo letterale. Anche quando il linguaggio è formalmente corretto persistono difficoltà nell'uso sociale (pragmatica).*

Criteri del DSM-5
A.1

A.1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva, che vanno da un approccio sociale anomalo al fallimento della reciprocità della conversazione; ridotta manifestazione di interesse, emozioni o affetto; fallimento nell'iniziare, terminare o rispondere all'interazione sociale.

È l'abilità di relazionarsi con gli altri e condividere pensieri e sentimenti.

Criteri del DSM-5
A.1 esempi

Quando sono piccoli o gravi

- Poca o nessuna iniziazione dell'interazione sociale
- Ridotta imitazione
- Linguaggio usato per richiedere o etichettare ma non per commentare

- Comunicazione unidirezionale
- Poca condivisione delle emozioni

Criteri del DSM-5
A.1 esempi

Grandi o lievi

- Elaborare o rispondere a stimoli sociali complessi
- Gestire emozioni complesse
- Quando entrare in una conversazione. Cosa è meglio non dire
- Necessità di "calcolare" cognitivamente ciò che è intuitivo per gli altri → Ansia sociale.

Criteri del DSM-5 A.2

A.2. Deficit nei comportamenti comunicativi non-verbali usati per la comunicazione sociale. Comunicazione verbale e non-verbale scarsamente integrata, contatto oculare o linguaggio del corpo anomalo, difficoltà nella comprensione e nell'uso dei gesti; mancanza di espressività facciale e comunicazione non verbale.

È strettamente legato al contesto culturale.

Comprende tutta la comunicazione non verbale (linguaggio del corpo, espressioni facciali, intonazione, prosodia della voce; sia negli aspetti ricettivi che espressivi).

Criteri del DSM-5 A.2 esempi

Età minore o gravità maggiore

- Mancanza di attenzione condivisa:
  - manifestata attraverso mancanza di *pointing*, mostrare, o portare e condividere oggetti di interesse.
  - Non seguire lo sguardo dell'altro (triangolazione)
- Repertorio di gesti inferiore a quanto ci si aspetterebbe per l'età di sviluppo.
- Mancato o povero uso di gesti od espressioni durante la comunicazione spontanea.
- Uso errato o idiosincratico di gesti od espressioni durante la comunicazione.

Criteri del DSM-5
A.2 esempi

Età maggiore o gravità minore

- Impressione del linguaggio del corpo "strano", "rigido" o "teatrale".
- Uso corretto delle singole modalità ma difficoltà ad integrarle. Es. linguaggio oculare presente ma mancanza di *coordinazione* tra sguardo, gesti, parole, etc.

Empatia e Teoria della Mente

- L'**empatia affettiva** è normale (e a volte superiore) nelle persone Asperger in quanto vivono le emozioni e le sensazioni in modo *più intenso*. Questo può provocare forte ansia e ritiro sociale, facendo sembrare il bambino privo di sentimenti.
- L'**empatia cognitiva** o **Teoria della Mente** è invece deficitaria in quanto hanno difficoltà a *prendere la prospettiva* dell'altro e capirne intenzioni, comportamento ed emozioni (a causa del differente modo di pensare tipico della loro mente e delle difficoltà nella lettura del linguaggio del corpo)

Criteri del DSM-5 A.3

A.3. Deficit nello sviluppare, mantenere o comprendere le relazioni. Difficoltà nell'adattare il comportamento ai diversi contesti sociali; difficoltà nella *condivisione* del gioco di fantasia o nel fare amicizie; apparente assenza di interesse verso i pari.

È importante ricordare che non servono tutte queste caratteristiche, ne basta una.

Sono 3 caratteristiche in una:

- *Interesse*
- *Comprensione*
- *Abilità*

A seconda di quale domina, cambia molto l'approccio da adottare.

Criteri del DSM-5
A.3 esempi

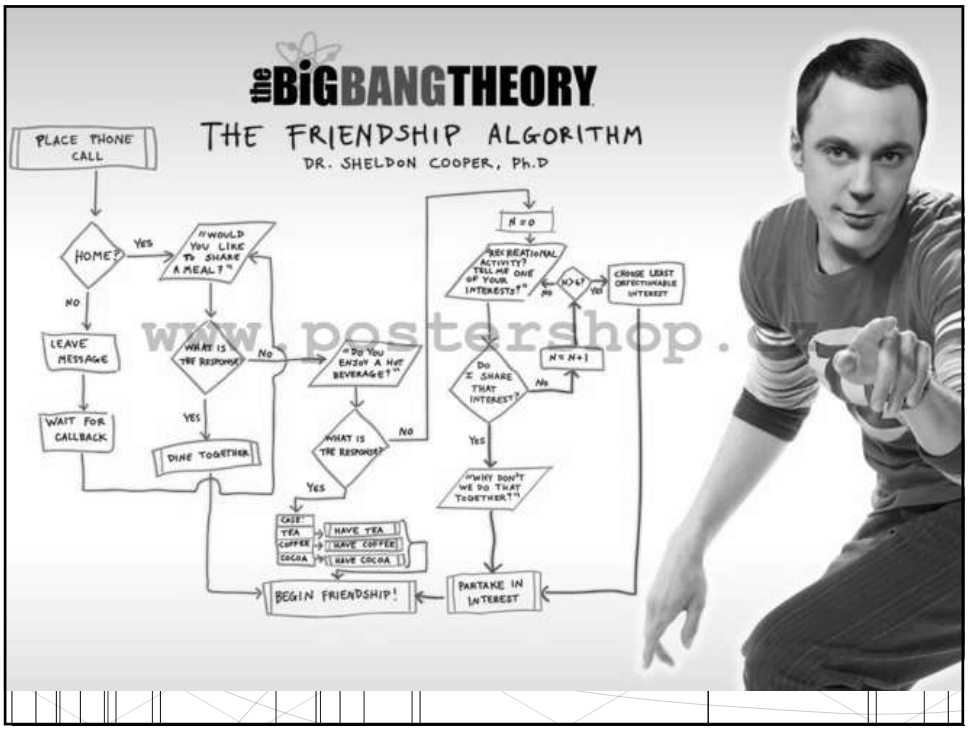
Età minore o gravità maggiore

- L'interesse può essere assente, ridotto o atipico (ad esempio si avvicina *troppo* agli altri, abbraccia tutti, è "iper-affettivo")
- Si manifesta attraverso l'emarginazione, la passività o comportamenti inappropriati che possono apparire aggressivi o ritirati.
- Mancanza di gioco sociale condiviso.
- Gioco solo "secondo le proprie regole".

Criteri del DSM-5
A.3 esempi

Età maggiore o gravità minore

- Atipicità si manifesta attraverso comportamenti che vengono letti come: intimidatori, "isterici", sessualmente provocatori, altezzosi, superbi, freddi.
- Appropriatezza del comportamento al contesto (es. linguaggio o vestiario *casual* ad un colloquio di lavoro).
- Ironia, sarcasmo, bugie bianche.
- Preferisce attività solitaria o compagnia di persone più piccole o più grandi.
- Vuole amicizie ma non capisce bene cosa comporta e qual è il senso dell'amicizia.
- Importante considerare le relazioni con: genitori, colleghi, datori di lavoro, partner, figli.



DSM-5 Cluster B

DSM-5 Cluster B

Schemi di comportamento, interessi o attività, ristretti o ripetitivi, manifestati da almeno due dei seguenti punti. Ora o nella storia clinica.

- Presentazione molto variabile a seconda dell'età, della gravità, dell'intervento svolto e **del supporto sociale**.
- Molti adulti senza ID "nascondono" i comportamenti ripetitivi in pubblico (anche se questo fa spesso aumentare l'ansia).

DSM-5 Cluster B

I criteri per i comportamenti o gli interessi ristretti sono soddisfatti anche se erano presenti durante l'infanzia (o nel passato) ma non sono più presenti (o osservabili).

Gli interessi speciali possono essere una fonte di piacere e motivazione e aprire la strada per l'educazione e il lavoro.

N.B. Questo è scritto nel DSM-5!

DSM-5 Cluster B

B.1. Movimenti motori, uso di oggetti o della parola ripetitivo o stereotipato

Stereotipie motorie semplici: *hand flapping*, *finger flicking*.

allineare gli oggetti o rotearli (rigirare monete o trottole)

ecolalia immediata o differita

Frasi, parole, prosodia idiosincratiche

DSM-5 Cluster B

B.2. Insistence on sameness (Insistenza nell'uguaglianza), aderenza inflessibile alle routine, o schemi di comportamento verbale o non verbale ritualizzati.

forte stress a seguito di piccoli cambiamenti, difficoltà con le transizioni,

schemi di pensiero rigidi, saluti stereotipati,

"necessità" di prendere la stessa strada tutte le volte che si fa un percorso, mangiare lo stesso cibo,

Rituali quali: domande incessanti, camminare in tondo…

DSM-5 Cluster B

B.3. Interessi ristretti e fissi che sono anormali nell'intensità o nel focus:

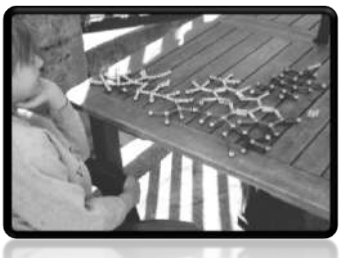
forte attaccamento o preoccupazione per oggetti inusuali, interessi eccessivamente circostanziati o perseveranti.

Interessi speciali

- Una delle caratteristiche che differenzia un hobby da un interesse speciale di rilevanza clinica è il focus verso l´interesse o la peculiarità dell´argomento
- Stadio 1. Parte di oggetti (luci, lavatrice, ventilatori).
- Stadio 2. Categoria di oggetti (tipici ed eccentrici). Fare finta di essere l'oggetto. Spesso mezzi di trasporto, animali e oggetti elettronici.

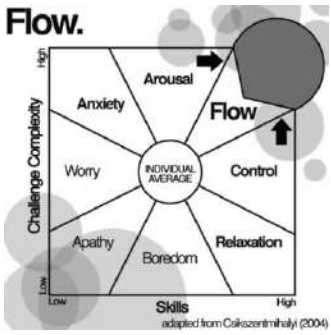
Interessi speciali

- Stadio 3. Interessi complessi ed astratti come periodi storici, geografia...
- Stadio 4. Interesse verso una persona, letteratura fantasy e molteplici interessi.



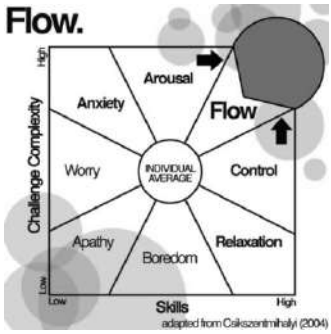
Interessi speciali

- La maggior parte della conoscenza che riguarda l´interesse speciale è autodidatta, autodeterminata, autonoma, intuitiva.
- Sembrano esserci due particolari categorie di interesse: la collezione e l´acquisizione della conoscenza di un argomento o concetto specifico



Interessi speciali

- La conoscenza per superare la paura
- Motivazione e concettualizzazione
- Assorbimento dell'attenzione con esclusione della consapevolezza (*flow*)→ esclusione dei pensieri negativi (ansia, rabbia, tristezza)
- Passione o **Ossessione** (possibile disturbo ossessivo-compulsivo)? È irresistibile?



Interessi speciali

- *Bilanciamento* ottimale per quel bambino in quel contesto di: *ansia, abilità ed attenzione*.
- Un mezzo per rilassarsi, attività piacevole
- Distrazione durante una crisi
- Interruttore di spegnimento.

DSM-5 Cluster B

B.4. Iper- o Ipo- reattività agli input sensoriali o interessi inusuali per aspetti sensoriali dell'ambiente

apparente indifferenza al dolore o temperatura,

risposta avversa a suoni o tessuti specifici,

eccessivo odorare o toccare o fascinazione visiva per luci o movimento.

Sensi e percezione

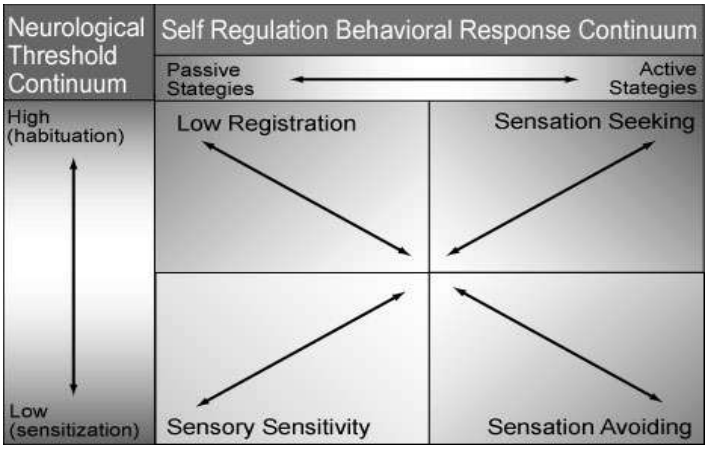
- I bambini ASD (sindrome di Asperger o autismo) percepiscono il loro mondo in modo molto diverso.
- Il meccanismo di filtro nel loro cervello lavora spesso in modo diverso nell'assimilare i sensi come il tatto, olfatto, udito, gusto e vista.
- Possono essere estremamente sensibile ad alcuni sensi e trovare gli eventi apparentemente di routine affascinanti - i modelli di luce su un muro, o le foglie fruscianti nel vento.
- Il bambino autistico può anche non rispondere alle sensazioni che i loro genitori trovano sgradevoli, come il calore estremo, il freddo o il dolore.

Sensi e percezione

- Ipersensibile (Cauto/Provocatore),
- Iposensibile
- Impulsivo (sensory seeking)

ZERO TO THREE: DC: 0-3R

Sensi e percezione



Dunn, W., Saiter, J., & Rinner, L. (2002). Asperger Syndrome and Sensory Processing A Conceptual Model and Guidance for Intervention Planning. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, *17*(3), 172-185.

Movimento e coordinazione

- Si nota una certa goffaggine motoria in almeno il 60% dei bambini con Asperger, più rara nell'autismo o un generale ritardo motorio.
- Quando camminano o corrono la coordinazione può risultare immatura e gli adulti possono avere un´andatura strana, a volte idiosincratica che manca di fluidità ed efficacia

Movimento e coordinazione

- Una descrizione più accurata del semplice essere goffi può essere una carente pianificazione di movimento e tempi lenti di pianificazione cognitiva del movimento.
- La goffaggine motoria sembra **non** interessare le attività sportive come il nuoto, l´utilizzo del trampolino, giocare a golf e l´equitazione.

Sensibilità sensoriale

- La sensibilità più comune è quella verso **suoni** specifici, ma ci possono essere anche sensibilità **tattili**, sensibilità riguardanti l´intensità della **luce**, il gusto e la consistenza di alcuni **cibi**, nonché la sensibilità verso certi **odori**.
- Ci può essere una reazione spropositata o al contrario sottotono rispetto ad un **dolore** fisico, al disagio e all´equilibrio, la percezione del movimento e l´orientamento corporeo possono risultare insoliti.

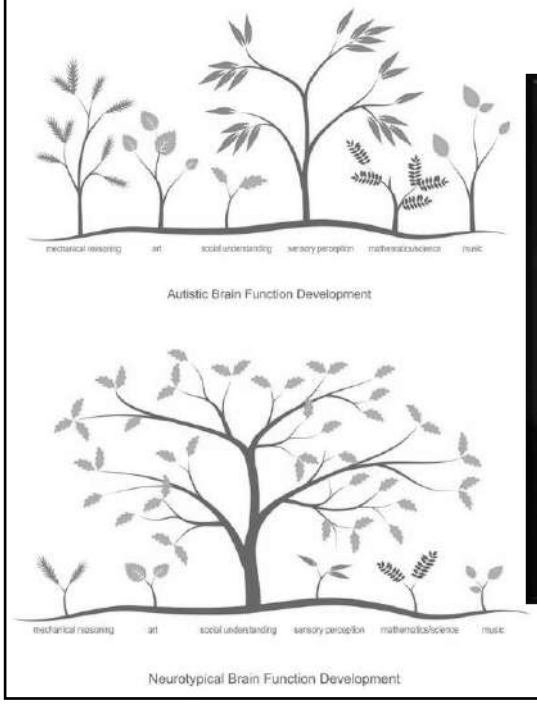
Sensibilità sensoriale

- In ambienti sensorialmente stimolanti, come ad esempio la classe, il bambino con una grande sensibilità sensoriale diventa **iper vigilante**, teso e distraibile, non sapendo quando arriverà la successiva dolorosa esperienza sensoriale

Neurodiversità

L'autismo rappresenta una differenza neurologica all'interno della naturale variazione tra gli esseri umani.
Condizione di variazione neurobiologica che determina una struttura cerebrale che elabora percezioni e pensieri diversamente rispetto alla maggioranza della popolazione, con conseguenze in ambito sociale, affettivo e lavorativo.

Judy Singer e Laurent Mottron



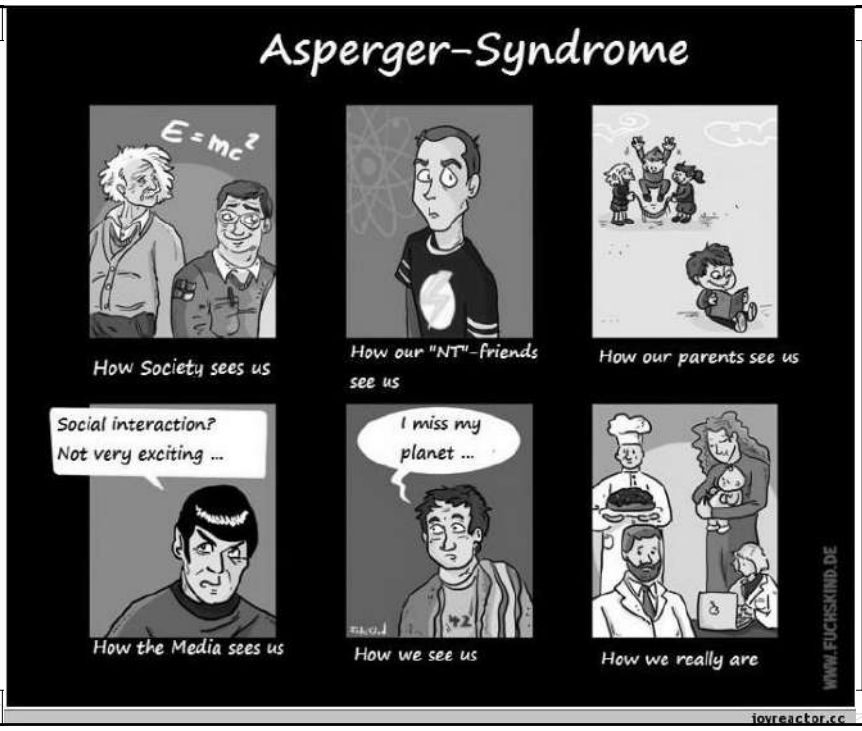
"Se persone normali si trovassero su un altro pianeta con creature aliene, probabilmente si sentirebbero spaventate, non saprebbero come fare per adattarvisi e avrebbero sicuramente difficoltà a capire cosa pensano, sentono e vogliono gli alieni e a rispondere correttamente a tutto questo. L' autismo è così."

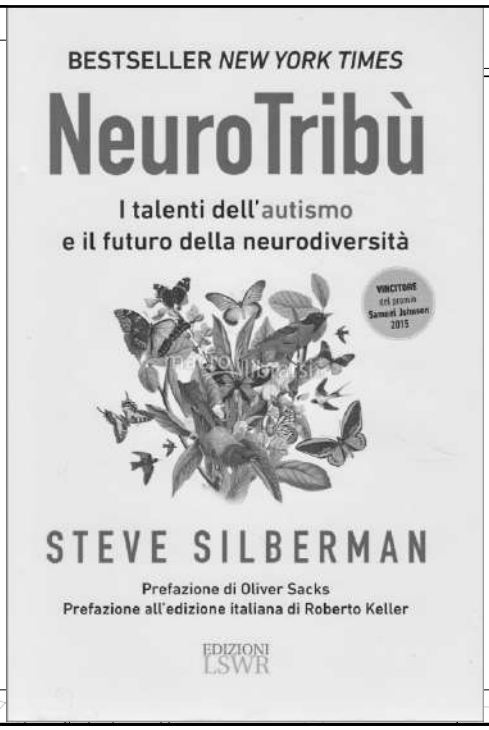
Therese Joliffe

"Sogno che un giorno un'astronave scenderà dal cielo sull'asfalto di fronte a me, e ne usciranno delle persone che mi diranno: «È stato tutto un terribile errore. Non saresti mai dovuta essere qui. Noi siamo il tuo popolo e siamo venuti per riportarti a casa".

"Se potessi schioccare le dita e non essere più autistica, non lo farei, perché non sarei più me stessa. L'autismo è parte di ciò che io sono."

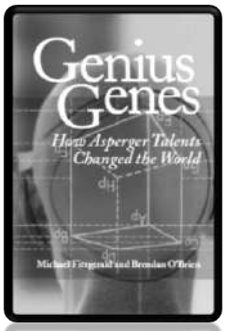
Temple Grandin



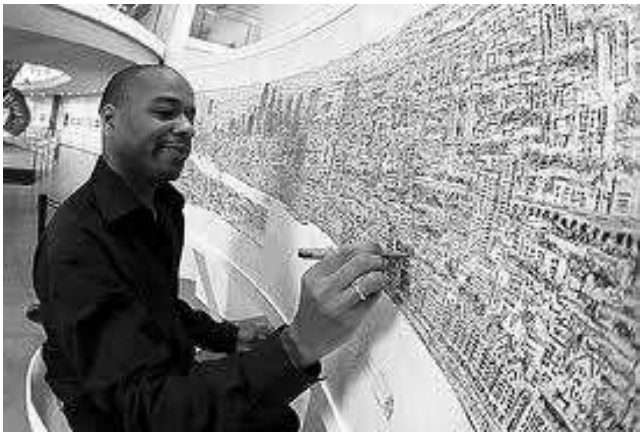


Citazioni di Hans Asperger.

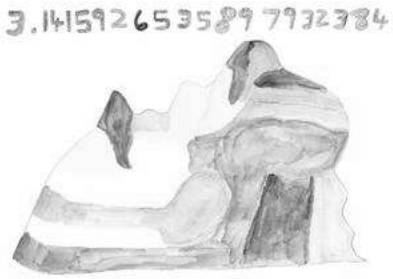
"Sembra che per avere successo nella scienza o arte, un pizzico di autismo sia essenziale. Per il successo, l'ingrediente necessario può essere la capacità di allontanarsi dal mondo quotidiano, dalla semplicità pratica, la capacità di ripensare un soggetto con originalità in modo da creare nove strade mai calpestate, con tutte le abilità canalizzate in un interesse." (1979).



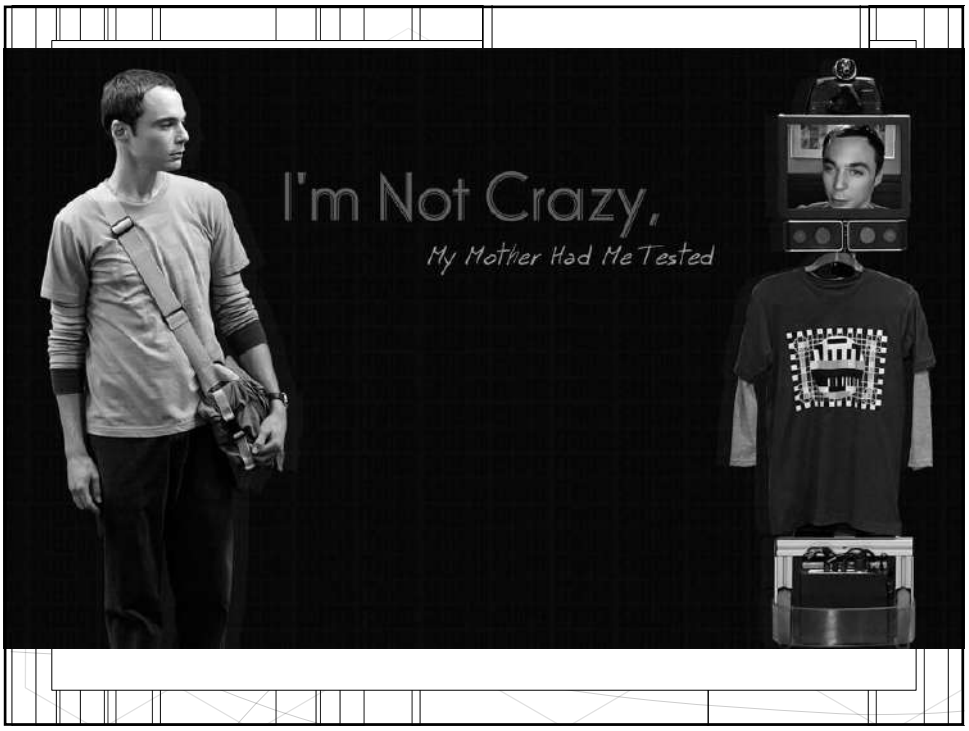
Stephen Wiltshire: The Human Camera



Stephen ha impiegato 30 minuti per memorizzare dalle montagne di Roppongi (270 metri) l'orizzonte di Tokio; nei sette giorni successivi lo ha disegnato a memoria in modo eccellentemente accurato.



Daniel Tammet detiene il record in Europa per aver recitato il Pi greco fino a 22.514 cifre in poco più di cinque ore. E' in grado di "vedere" se un numero sia primo o composto è ha imparato l'islandese in una settimana


I'm Not Crazy,
My Mother Had Me Tested

La chiave del successo

- L´unico tratto comune di tutte le "storie di successo" è stato un intervento educativo precoce ed individualizzato. Molti ragazzi hanno una persona che lavora accanto a loro a scuola o fuori scuola, altri sono stati fatti studiare a casa, o a casa hanno ricevuto indicazioni ed integrazioni.
- **L´opportunità del supporto deve e può essere utilizzata non solo per far fronte alle difficoltà ma anche per sviluppare talenti e strategie.**

Conclusione

- Quando hai visto una persona Asperger hai visto solo UNA persona Asperger.
- "Non conosco nessuno che sia del tutto autistico o del tutto neurotipico. Anche Dio ha i suoi momenti autistici, è per questo che i pianeti girano."
- *- Jerry Newport -*

GRAZIE!
“ A volte la vera bellezza è proprio nella diversità. ”